

TURP — Cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo (TURP)

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật tiêu chuẩn lâu đời cho tuyến tiền liệt phì đại

WARWIKI

TURP là phẫu thuật phổ biến và hiệu quả đã được kiểm chứng cho tình trạng tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH) gây tắc nghẽn dòng tiểu. Bác sĩ đưa ống nội soi qua niệu đạo — **không cần rạch da ngoài** — và cắt bỏ mô tuyến tiền liệt phía trong đang chèn ép đường tiểu. Phẫu thuật cải thiện dòng tiểu rõ rệt và bền lâu, với hàng thập kỷ theo dõi lâm sàng.

Về ca phẫu thuật này

Một dụng cụ mỏng gọi là **ống cắt nội soi (resectoscope)** được đưa qua niệu đạo. Bác sĩ dùng vòng điện nhỏ cắt bỏ từng phần mô tuyến tiền liệt phía trong đang gây tắc, mở rộng đường tiểu. Phần vỏ ngoài tuyến tiền liệt được giữ nguyên. Sau phẫu thuật, một ống thông được đặt vào để bàng quang lành lại.

Có an toàn không?

TURP là một trong những phẫu thuật tiết niệu được nghiên cứu nhiều nhất và rất hiệu quả. Như mọi phẫu thuật, có các rủi ro như chảy máu, nhiễm trùng, kích ứng tạm thời — và một số thay đổi lâu dài cần lưu ý (xem bên dưới). Phẫu thuật phù hợp nhất với tuyến tiền liệt **kích thước vừa phải**; tuyến rất lớn có thể phù hợp hơn với HoLEP, Aquablation, hoặc cắt tuyến tiền liệt đơn thuần.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

TURP

Cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo — phẫu thuật nội soi điều trị BPH.

BPH

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (không phải ung thư).

Resectoscope

Ống nội soi có vòng cắt dùng để cắt bỏ mô tuyến tiền liệt.

Xuất tinh ngược dòng

Tinh dịch đi ngược vào bàng quang — tác dụng phụ phổ biến, vô hại.

Ống thông

Ống dẫn nước tiểu ra ngoài bàng quang trong 1–3 ngày sau phẫu thuật.

Rửa bàng quang

Tưới nhẹ qua ống thông để làm sạch máu trong giai đoạn đầu.

SAU PHẪU THUẬT CÓ GÌ THAY ĐỔI? Hầu hết nam giới có dòng tiểu mạnh hơn rõ rệt. Thay đổi lâu dài phổ biến nhất là **xuất tinh ngược dòng** — tinh dịch đi ngược vào bàng quang, cảm giác cực khoái bình thường nhưng ít hoặc không có dịch ra ngoài. Điều này vô hại (dù ảnh hưởng đến khả năng sinh sản). Rối loạn cương dương hoặc tiểu không kiểm soát nghiêm trọng là hiếm gặp.

Cách chuẩn bị

- Phẫu thuật thực hiện dưới **gây tê tùy sống hoặc gây mê toàn thân** — tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc (ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng trước phẫu thuật.
- Sắp xếp người đưa đón; chuẩn bị mang ống thông trong vài ngày.

Quá trình & Sau khi phẫu thuật

1. Bạn được gây mê hoặc gây tê; kháng sinh được dùng trước.
2. Mô tuyến tiền liệt gây tắc được cắt bỏ qua ống nội soi.
3. Đặt ống thông, đôi khi kèm rửa bàng quang nhẹ trong ngày đầu.
4. Thường nằm viện một đêm; rút ống thông sau **1–3 ngày**.

Dự kiến **nước tiểu có lẫn máu** và cảm giác nóng rát/tiểu gấp trong vài tuần; uống nhiều nước, tránh rượu và mang vật nặng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Bạn **không tiểu được** sau khi rút ống thông
- **Chảy máu nhiều hoặc có cục máu đông** gây tắc
- Sốt hoặc ớn lạnh
- Chảy máu ngày càng nhiều (chảy máu nhẹ quanh tuần 1–2 là thường — hãy nghỉ ngơi và uống nhiều nước)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. TURP cắt bỏ mô tuyến tiền liệt phía trong qua ống nội soi (không rạch da) — phương pháp tiêu chuẩn lâu đời, rất hiệu quả cho BPH mức độ vừa.
2. Dòng tiểu sẽ mạnh hơn; thay đổi lâu dài phổ biến là xuất tinh khô/ngược dòng (vô hại).
3. Nước tiểu có máu và kích ứng sẽ giảm dần trong vài tuần. Gọi ngay nếu không tiểu được, chảy máu nhiều, hoặc sốt.